

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

PACIENTE

Sebastián Quintero Luna

DOCUMENTO

CC 1006123456

FECHA NACIMIENTO

17/02/2003

EDAD

23 años, 3 meses

SEXO

Masculino

ESCOLARIDAD

Técnico (Sistemas)

LATERALIDAD

Diestro

FECHA DE EVALUACIÓN

15/06/2026

ORDEN N°

OM-2026-001245

PROTOCOLO APLICADO

WAIS-III + BDI-II + Evaluación Post-TCE

ELABORADO POR

Profesional admin-read

Psicólogo

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Sebastián Quintero Luna	Lateralidad:	Diestro
Documento:	CC 1006123456	Ocupación:	Técnico en sistemas
Fecha de nacimiento:	17/02/2003	Ciudad:	Ibagué, Tolima
Edad:	23 años, 3 meses	Acompañante:	Rosa Luna de Quintero
Sexo:	Masculino	Remite:	Neurólogo
Escolaridad:	Técnico (Sistemas)	EPS / Asegurador:	Nueva EPS

MOTIVO DE CONSULTA

TCE leve por accidente de tránsito hace 5 meses. Pérdida de conciencia <30 min. Cefalea post-traumática persistente, quejas de memoria y concentración. Reinicio laboral fallido.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: WAIS-III + BDI-II + Evaluación Post-TCE

Prueba	Dominio	Dur.
VOCABULARIO	Comprensión Verbal	—
SEMEJANZAS	Comprensión Verbal	—
ARITMETICA	Comprensión Verbal	—
DIGITOS	Atención	—
FIG. INCOMPLETAS	Organización Perceptual	—
CLAVE DE NÚMEROS	Velocidad de Proceso	—
CONSTRUCCIÓN CUBOS	Organización Perceptual	—
MATRICES	Organización Perceptual	—
CI COMPRENSIÓN VERBAL	Índice CI	—
CI DEL INDICE ORGNIZACIÓN PERCEPTIVA	Índice CI	—
CI INDICE MEMORIA DE TRABAJO	Índice CI	—
CI INDICE VELOCIDAD DE PROCESO	Índice CI	—
CI ESCALA TOTAL	Inteligencia General	—
Inventario de Beck BDI-II	Socioemocional - Depresión	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Sin antecedentes psiquiátricos previos.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Niega TEC previo.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica completa. Paciente colaborador. Sin incidentes durante la aplicación.

Atención y concentración

Atención sostenida y selectiva descendidas. Fatiga atencional acelerada. Mejora con pausas estructuradas.

Memoria

Memoria de trabajo descendida. Codificación deficiente. Reconocimiento mejor que evocación libre (perfil subcortical).

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo global: S06.0 - Secuelas de traumatismo craneoencefálico leve

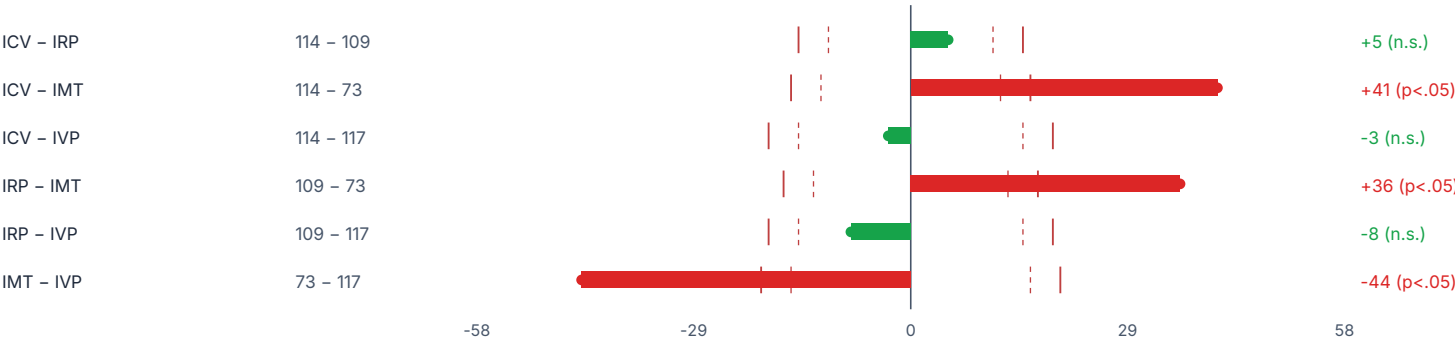
RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes estandarizados y perfil cognitivo

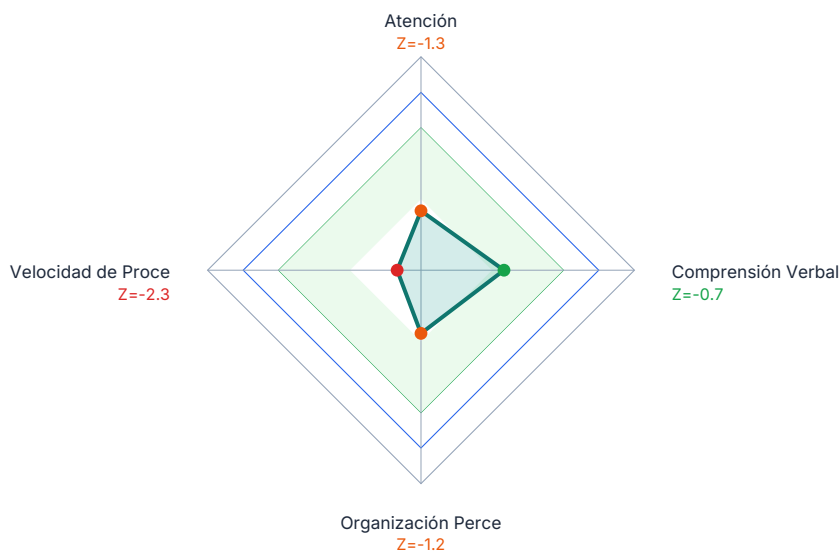


Discrepancias entre índices

Diferencia = valor del primer índice - segundo. Líneas críticas según Wechsler ($p < .15$... y $p < .05$).

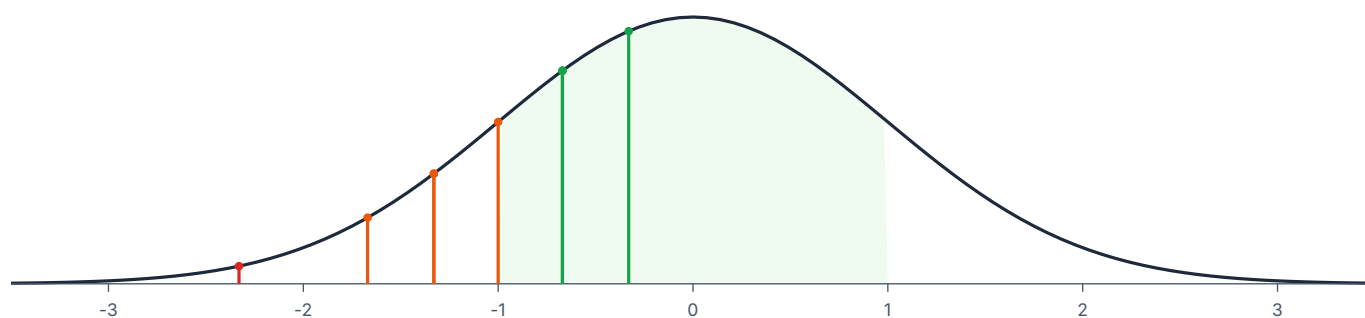


Perfil cognitivo por dominio



Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 8 pruebas con norma disponible



Perfil Z por prueba

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
VOCABULARIO							-1.00
SEMEJANZAS							-0.67
ARITMETICA							-0.33
DIGITOS							-1.33
FIG. INCOMPLETAS							-1.67
CLAVE DE NÚMEROS							-2.33
CONSTRUCCIÓN CUBOS							-1.33
MATRICES							-0.67
CI COMPRENSIÓN VERBAL							+0.93
CI DEL INDICE ORGNIZACIÓN PERCEP							+0.60
CI INDICE MEMORIA DE TRABAJO							-1.80
CI INDICE VELOCIDAD DE PROCESO							+1.13
CI ESCALA TOTAL							-1.53
Inventario de Beck BDI-II							-5.47

Banda verde = rango normal (-1 a +1 σ). Z<-1 sugiere debilidad. Z>+1 sugiere fortaleza relativa.

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
VOCABULARIO	32	7	-1.00	Promedio
SEMEJANZAS	16	8	-0.67	Promedio
ARITMETICA	12	9	-0.33	Promedio
DIGITOS	11	6	-1.33	Límitrofe
FIG. INCOMPLETAS	14	5	-1.67	Límitrofe
CLAVE DE NÚMEROS	35	3	-2.33	Bajo
CONSTRUCCIÓN CUBOS	30	6	-1.33	Límitrofe
MATRICES	16	8	-0.67	Promedio
CI COMPRENSIÓN VERBAL	38	114	+0.93	Promedio
CI DEL INDICE ORGNIZACIÓN PERCEPTI	35	109	+0.60	Promedio
CI INDICE MEMORIA DE TRABAJO	18	73	-1.80	Límitrofe
CI INDICE VELOCIDAD DE PROCESO	26	117	+1.13	Promedio
CI ESCALA TOTAL	78	77	-1.53	Límitrofe
Inventario de Beck BDI-II	18	18	-5.47	Leve

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

Sebastián obtuvo un Cociente Intelectual Total (CIT) de 77, ubicándose en la categoría límiterofe (percentil aproximado 6). Se observa una variabilidad relevante entre sus índices compuestos: el más bajo corresponde a IMT (73) y el más alto a IVP (117), lo que sugiere un perfil asimétrico que conviene analizar por separado más que resumir en una única puntuación global.

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: velocidad de proceso (severamente disminuido, $Z=-2.3$); atención (moderadamente disminuido, $Z=-1.3$); organización perceptual (moderadamente disminuido, $Z=-1.2$).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran CLAVE DE NÚMEROS ($Z=-2.33$, bajo); FIG. INCOMPLETAS ($Z=-1.67$, límiterofe); DIGITOS ($Z=-1.33$, límiterofe). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido

- CLAVE DE NÚMEROS — bajo ($Z=-2.33$)
- FIG. INCOMPLETAS — límiterofe ($Z=-1.67$)
- CONSTRUCCIÓN CUBOS — límiterofe ($Z=-1.33$)
- DIGITOS — límiterofe ($Z=-1.33$)
- VOCABULARIO — promedio ($Z=-1.00$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Sebastián. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En AdWAISV, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En AdSemWais, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En AdWAISA, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En AdSDWais, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En AdWAISV, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En AdSemWais, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En AdWAISA, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En AdMatr, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En AdWAISICV, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En AdSDWais, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

¿Qué recomendamos?

Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta.

Preguntas frecuentes

- ¿Mis resultados son permanentes?
No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica y los apoyos adecuados. Los resultados que obtuviste son una foto del momento actual.
- ¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?
Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto no significa que haya algo mal en ti.
- ¿Necesito otro tipo de evaluaciones?
Tu psicólogo/a te dirá si se necesitan otros estudios (por ejemplo, evaluación pedagógica, médica, o del lenguaje). No te preocupes si no entiendes algún término: puedes preguntar siempre.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: S06

Impresión diagnóstica: S06.0 - Secuelas de traumatismo craneoencefálico leve

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

- Se recomienda seguimiento clínico y plan terapéutico según hallazgos. Reevaluación en 6-12 meses si aplica.